

時間依存性神経救急、局在診断、機能低下

急性局在性障害は脳卒中として扱う

- 再灌流の利益は時間とともに減る
- 後方循環は複視、嚥下障害、体幹失調
- 得点が低くても良性ではない
- 不確実性は画像検査を早める理由
- 低血糖、発作後麻痺、片頭痛前兆が模倣
- 単純コンピュータ断層撮影で出血と占拠効果
- 虚血早期には正常なことがある

画像と再灌流療法

- 血管撮影で大血管閉塞と動脈解離
- 出血除外後に静注血栓溶解療法
- 機械的血栓回収療法は選択例の血栓除去
- 両者は競合せず補完する
- 適格なら完全な診断確定を待たない

再灌流判断後の管理

- 経口摂取前に嚥下を評価
- 不顕性誤嚥が多い
- 二次予防は機序に従う
- 非心原性には多くは抗血小板薬
- 適切な心房細動には抗凝固薬
- 申し送りは時刻、抗血栓薬最終服用、画像
- 自然改善は一過性脳虚血発作か再開通
- 原因不明なら仮説に沿い心律動・血管評価

発作の再構成と重積

- 名称を付ける前に出来事を再構成
- 前兆が局在性発症を示す
- 舌側縁損傷と発作後混乱は支持、必須でない
- 尿失禁と失神後ミオクローヌスは非特異的
- 重積は発作終結機構の失敗
- 五分で十分量のベンゾジアゼピン
- 続いて長時間作用型薬、原因検索
- 運動停止後の無反応は脳波で識別
- 初回発作は誘発性か非誘発性か
- 誘因があっても構造病変を除外しない

神経変性と縦断診療

- 最初に優位に障害されるネットワーク
- レビー小体型認知症は変動、幻視、睡眠
- 抗精神病薬への顕著な過敏性
- 行動型前頭側頭葉変性症は脱抑制、無気力
- パーキンソン病は動作緩慢に固縮が振戦
- 運動ニューロン疾患は感覚症候群なし
- 四肢低下なしに呼吸不全が進む
- 条件をそろえて反復測定
- 階段状悪化は感染、薬剤、血管障害を探す
- 意思を伝えられるうちに話し合う

どこで、何が、どの速さで

- 突然最大は血管閉塞、出血、発作、外傷
- 数時間から数日は炎症、感染、代謝、拡大病変
- 数週から数か月は腫瘍、免疫、圧迫、変性
- 最終正常確認時刻からの精密な時系列

虚血の生理と治療選択

- 動脈閉塞と側副血行不全
- 中心部はエネルギー不全、浮腫、細胞死
- ペナンプラは膜より先に電気機能が消失
- 再開通と側副血行は時間枠を超え温存
- 時刻、画像、出血リスクを統合して選択
- 低血圧、低酸素、発熱で中心部へ

出血

- 脳内出血は最初の数時間に拡大し得る
- 深部出血は高血圧性小血管障害
- 高齢者の脳葉出血は脳アミロイド血管症
- 小脳出血は脳幹圧迫、脳脊髄液流閉塞
- くも膜下出血は数秒から数分で最大の頭痛
- 緊急除去を要することがある
- 早期の動脈瘤閉鎖で再出血を防ぐ
- ニモジピンで遅発性脳虚血の不良転帰減少

頭蓋内圧亢進

- 予備能消失中も圧は正常に見え得る
- 晩期に瞳孔不同、伸展肢位、不規則呼吸
- 低血圧は灌流圧を両側から悪化
- その後急峻な圧上昇、偏位、ヘルニア
- 頸部正中で頭部挙上、低張液を避ける
- 高張食塩水かマンニトールで浸透圧勾配
- 容量、ナトリウム、腎、血行動態への影響
- 短時間の過換気は脳血管を収縮
- 長時間では脳虚血を起こす
- 圧勾配で組織偏位し得れば腰椎穿刺延期

筋力低下の局在とギラン・バレー

- 上位運動ニューロンは筋緊張・反射亢進
- 下位運動ニューロンは萎縮、線維束性収縮
- 神経筋接合部は変動性・易疲労性、感覚保持
- 伝導検査正常でも小線維障害は除外不可
- ギラン・バレー症候群は神経・自律神経救急
- 四肢筋力は呼吸悪化を過小評価
- 努力性肺活量、咳、嚥下を反復監視
- 二酸化炭素上昇前に挿管が必要
- 自律神経障害で血管作動薬は危険
- 免疫グロブリンか血漿交換、併用利益なし